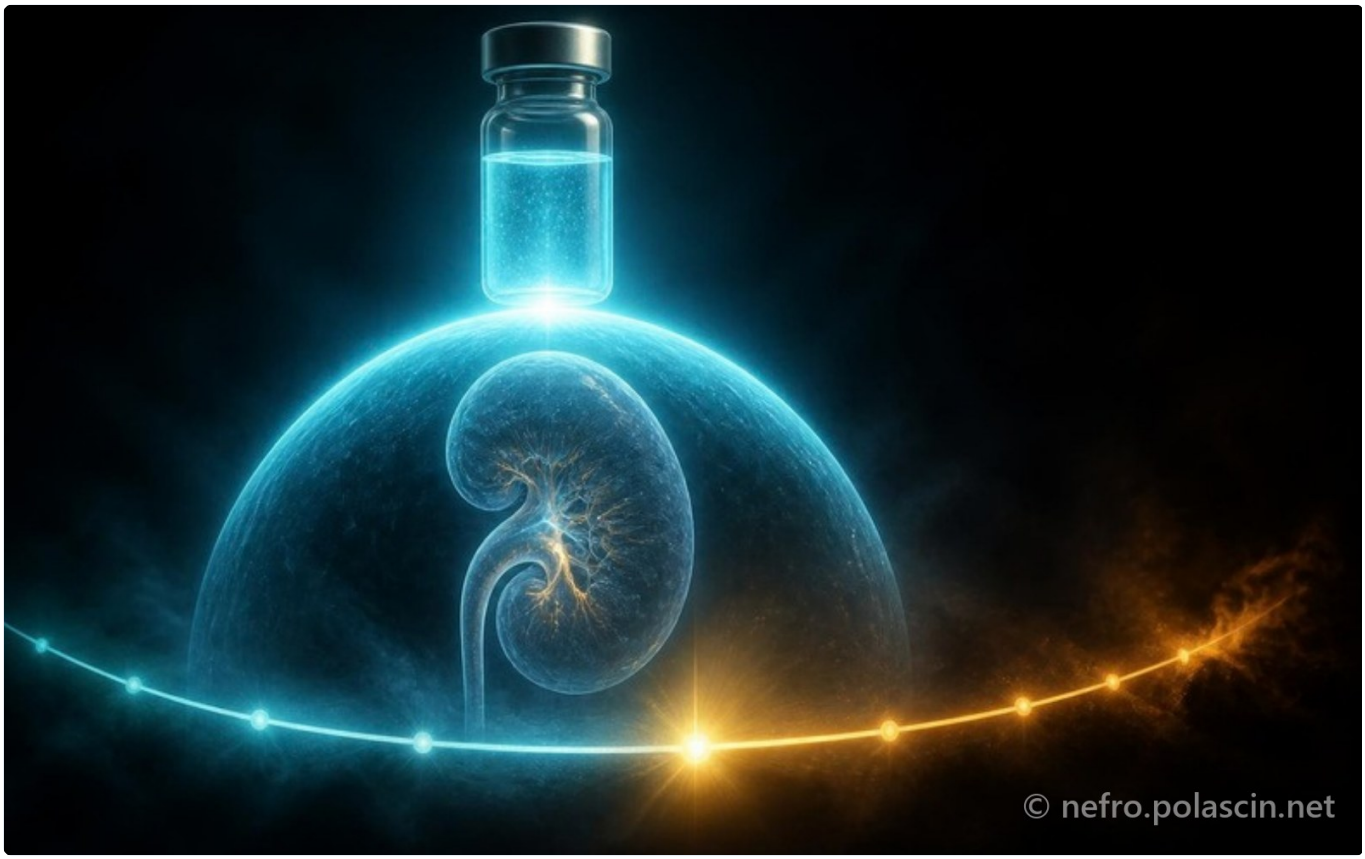
Očkovanie pri chronickej chorobe obličiek (CKD) a po transplantácii obličky: praktický prehľad vakcín a načasovania

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Ochrana je najsilnejšia, keď sa očkuje včas – po transplantácii je odpoveď imunitného systému slabšia.

Pacienti s chronickou chorobou obličiek a najmä po transplantácii obličky majú vyššie riziko závažných infekcií. Dôvodom je kombinácia zhoršenej imunitnej odpovede pri CKD a imunosupresie po transplantácii, ako aj častý kontakt so zdravotníckym prostredím (dialýza, ambulantné sledovanie). Očkovanie preto patrí medzi základné preventívne kroky.

Nižšie zhŕňam odporúčania z prehľadu „Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation“ so zameraním na indikácie, načasovanie a typ vakcíny.

Kľúčové princípy pri CKD a po transplantácii

V prehľade sa opakovane zdôrazňuje, že:

- o očkovaní sa rozhoduje podľa rizika (CKD štádium, vek, dialýza, typ imunitnej supresie),
- po transplantácii treba dodržať vhodný odstup očkovania od zákroku,
- pri transplantovaných pacientoch treba brať do úvahy špecifiká imunitnej odpovede a typ vakcíny (napr. pri chrípke sa uvádza zákaz živých vakcín).

Prehľad vakcín podľa infekcie

Influenza (chrípka)

- **Indikácia pri CKD aj po transplantácii:** pre všetkých pacientov **každoročne**.
- **Po transplantácii:** začať **4 týždne po transplantácii**, pričom sa uvádza *„no live vaccine“* (t. j. nepoužívať živé vakcíny).

- **Po transplantácii podľa veku:**
    - **vek < 60 rokov:** štandardná jednorazová očkovacia schéma,
    - **vek ≥ 60 rokov:** *high-dose* (jednorazová schéma).

Pneumokok (Pneumococcus)

- **Indikácia pre CKD:** všetci pacienti **vo veku ≥ 19 rokov**.
- **Po transplantácii:** začať **6 mesiacov po transplantácii**.
- **Schéma podľa predchádzajúceho očkovania:**
    - ak pacient **ešte nebol očkovaný: 1× PCV**,
    - ak pacient **už dostal PPSV23: 1× PCV booster > 1 rok po PPSV23**.

RSV (respiračný syncyciálny vírus)

- **CKD:** všetci vo veku **≥ 75 rokov**, pri ktorých ide o **CKD 3+**.
- **Dialýza:** všetci vo veku **≥ 60 rokov**.
- **Po transplantácii:** všetci vo veku **≥ 60 rokov**, začať **6 mesiacov po transplantácii**.
- **Schéma: jedna dávka**, bez preferencie typu vakcíny.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

- **CKD:** pre všetkých pacientov **každoročné revakcinácie**.
- **Po transplantácii:** rovnako **každoročná revakcinácia**, pri úvahe sa spomína **interval 6 mesiacov**.
- **Typ: jednodávková mRNA vakcína** s **aktuálnym variantom vírusu** (*most recent virus variant*).

Hepatitída B

- **CKD:** všetci pacienti so **CKD 3b–5**.
- **Po transplantácii:** v prehľade sa pri špecifikách uvádza *„No specific recommendation“*.
- **Schéma pri CKD:**
    - **3 až 4 injekcie** buď bežnej, alebo **dvojitej dávky** (podľa SPC príslušného prípravku),
    - **sérologické monitorovanie** a následné **preočkovanie (booster)** ako stratégia.

Herpes zoster (pásový opar)

- **Pri CKD podľa veku (hranice podľa jurisdikcie):**
    - **ACIP:** od **≥ 50 rokov**,
    - **RKI:** od **60 rokov**,
    - **NHS:** od **65 rokov**.
- **Pri imunokompromitovaných:** pacienti **≥ 19 rokov** s **terapeutickou imunosupresiou**.
- **Po transplantácii:** v prehľade je uvedené, že očkovanie sa týka **všetkých vo veku ≥ 19 rokov** (s výnimkou režimu RKI, kde je hranica **≥ 50 rokov**).
- **Schéma: 2 dávky rekombinantnej vakcíny** podané **2 až 6 mesiacov** od seba.

Meningokok

- **CKD:** len pri **špecifických rizikách**, napr.:
    - asplénia,
    - inhibícia komplementu,
    - cestovanie do endemických oblastí.
- **Po transplantácii:** rovnaký princíp špecifického rizika.
- **Typ vakcíny v texte: MenB alebo MenACWY** podľa epidemiologickej situácie.
- **Schéma: jedna dávka**; treba **vyhodnotiť potrebu dodatočnej antibiotickej profylaxie**.

HPV (ľudský papilomavírus)

- **CKD:** v prehľade sa uvádza pre **deti 9–14 rokov**, „catch-up“ až do **26 rokov**.
- **Schéma:** rozšírená očkovacia schéma = **3 injekcie** v mesiacoch **0, 2, 6**.

Tetanus, difténia, pertusis (Tdap/Td)

- **Indikácia:** všetci pacienti **každých 5 až 10 rokov** (rovnako uvedené pre CKD aj po transplantácii).
- **Schéma: jednorazová kombinovaná vakcína**.

Praktické zhrnutie pre nefrologickú ambulanciu

Pre prax je najcennejšie, že prehľad dáva jasný časový rámec pre dospelých s CKD a pre načasovanie po transplantácii: chrípka po transplantácii od 4 týždňov, pneumokok od 6 mesiacov, RSV od 6 mesiacov, a pri vybraných vakcínach schémy dávok s explicitnými časovými intervalmi.

Ambulantná pomôcka: očkovanie dospelých s CKD a po transplantácii

Použite ako rýchlu kontrolu v ambulancii. Konkrétny prípravok, dávku a dostupnosť vždy overte podľa miestnych odporúčaní a údajov o prípravku.

1) Dospelý s CKD (chronická choroba obličiek)

Infekcia	Kedy je indikované	Schéma podľa prehľadu
Influenza	**všetci**, **každoročne**	**1× ročne**
Pneumokok	**vek ≥ 19 rokov**	podľa predchádzajúceho očkovania: buď **1× PCV** (ak nikdy), alebo **1× PCV booster > 1 rok po PPSV23**
RSV	**vek ≥ 75 rokov**, pri **CKD 3+**	**1 dávka**
SARS-CoV-2 (COVID-19)	**všetci**, **každoročne**	**1× ročne**, podľa aktuálneho variantu
Hepatitída B	**CKD 3b–5**	**3–4 injekcie** (bežná alebo dvojitá dávka podľa konkrétnej vakcíny), so **sérologickým monitorovaním a boosterom**
Herpes zoster (pásový opar)	vekové hranice podľa jurisdikcie v prehľade (ACIP ≥ 50, RKI ≥ 60, NHS ≥ 65)	**2× rekombinantná vakcína**, **2–6 mesiacov** od seba
Meningokok	len **pri špecifických rizikách** (napr. asplénia, inhibícia komplementu, cestovanie)	**podľa rizika**; v prehľade **MenB alebo MenACWY**, hodnotiť aj potrebu antibiotickej profylaxie
HPV	v prehľade **9–14 rokov** a catch-up do **26 rokov**	**3 injekcie** (mesiace **0, 2, 6**)
Tetanus/difténia/pertusis (Tdap/Td)	**všetci**, každých **5–10 rokov**	**1×** kombinovaná vakcína

2) Pacient po transplantácii obličky

Infekcia	Kedy začať po transplantácii	Schéma podľa prehľadu
Influenza	**od 4 týždňov**	**každoročne**; **nie živá vakcína**; vek < 60 štandardná, vek ≥ 60 **high-dose**
Pneumokok	**od 6 mesiacov**	podľa histórie: **1× PCV** ak nikdy, alebo **1× PCV booster > 1 rok po PPSV23**
RSV	**od 6 mesiacov**; vek ≥ 60	**1 dávka** (typ vakcíny v prehľade bez preferencie)

Infekcia	Kedy začať po transplantácii	Schéma podľa prehľadu
SARS-CoV-2	v prehľade ako každoročná revakcinácia	**1× ročne**, **mRNA**, *most recent virus variant*; pri úvahe sa spomína interval **~6 mesiacov**
Hepatitída B	po transplantácii: v prehľade **bez špecifického odporúčania**	sledujte podľa predošlej imunity a lokálnych protokolov
Herpes zoster	v prehľade plošne podľa veku	**všetci ≥ 19 rokov** (okrem výnimky pri RKI v prehľade); **2 dávky** s intervalom **2–6 mesiacov**
Meningokok	len pri špecifických rizikách	**MenB alebo MenACWY** podľa situácie; zhodnotiť antibiotickú profylaxiu
Tdap/Td	bez špecifického odkladu v prehľade	**1×** každých **5–10 rokov**

Rýchly postup v ambulancii (1 minúta)

1. **Zistiť diagnózu a režim:** CKD (štádium) alebo transplantácia (imunosupresia).
2. **Vybrať skupinu:** tabuľka pre CKD alebo pre transplantovaných.
3. **Skontrolovať históriu očkovania** (najmä pneumokok, hepatitída B, zoster).
4. **Doplniť, čo chýba** podľa časových odkladov po transplantácii (najmä chrípka 4 týždne, pneumokok/RSV 6 mesiacov).

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD): „Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation: A Review“.* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ockovanie-ckd-transplantacia-oblicky-vakciny-nacasovanie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.